

きょうの紙面 心臓リハ／嚥下スクリーニング／脳卒中／実施可能性RCT／ 短信5本

■ 心臓リハ／嚥下スクリーニング

心リハの退院支援に 「飲み込み」の確認を

「疑い」を拾い、食事と生活の支援につなぐ

徳島の75歳以上59人を調べた前向き観察研究。嚥下スクリーニング陽性は約半数で、退院時のADLも低かった。歩行・運動と合わせて見たい視点だ。

北島田岡病院の入院心リハ患者を、入院3日以内にEAT-10と反復唾液嚥下テスト（RSST）で評価した。どちらかが基準を満たす「嚥下障害疑い」は59人中29人。機器による確定診

断ではない。陽性群は入院時の握力、下腿周囲長、身体機能が低く、退院時Barthel Indexも中央値80点に対し陰性群85点だった。自宅からの入院者では退院先や介

護認定にも差が見られた。単施設・少人数の観察研究で、嚥下の問題が退院先を決めたとは言えない。重い認知機能障害などの除外もある。それでも、

心リハの退院支援で嚥下を拾い、多職種の評価につなぐ視点を示す。7月22日先行公開の論文。

Circulation Reports／J-STAGE

59人

75歳以上の入院患者

29人

スクリーニング陽性

49.2%

対象内での陽性割合

■ 脳卒中／実施可能性RCT

多点FES、16人が完遂 有効性の結論は次の試験へ

スペインの亜急性期脳卒中16人を8人ずつ割り付け。日常診療で続けられるかを調べた小規模試験。

発症6か月以内の上肢障害に対し、FES併用または通常リハを40分、週2回、6週間行った。全員が12回を完遂。FES群2人に一過性の皮膚発赤があり、重篤な有害事象はなかった。

主目的は実施可能性・使いやすさ・安全性。運動機能の探索的結果は信頼区間が広く、「手がよく動くようになる」と断定できない。次の十分な規模の試験を設計する材料だ。

Frontiers in Rehabilitation Sciences

■ 線維筋痛症／横断研究

検査室でできることと 日常でしていることを分ける

スペイン4病院の女性87人。身体検査、活動量計、患者報告を合わせて機能を評価した。

6分間歩行、握力、移動・バランスの検査に加え、加速度計と質問票を用いた。因子分析では身体機能、活動行動、心理的苦痛、痛み・症状負担の4因子が全体の67.1%を説明。日常活動は身体検査とは別

の軸を持った。検査値だけで暮らしを代弁せず、本人の経験と日常の活動も見る。女性のみの横断研究で、評価の組合せによる治療成績改善を証明したものではない。

Frontiers in Rehabilitation Sciences

短信

■ 呼吸リハ

簡単な道具で届く呼吸リハ

20報のナラティブレビュー。COPD中心で異質性があり、費用対効果と長期持続性の検証は不足。

Frontiers

■ 心臓リハ

退院前の対話を参加の入口に

9月11日の招待論評。看護師による短い心理教育を論じる。参加継続や実装への効果は今後の検証課題。

Eur J Cardiovasc Nurs

■ 医療AI

高精度の前に入力の時点を確認

米国調査44万人、10モデルの監査。診断後情報を除くとAUROCが約0.05低下。将来予測の試験ではない。※査読前

arXiv

■ 医療AI

研究対象のモデルは今も使うものか

医療LLMの文献11,628件を解析。モデル公開から評価公表までの遅れが拡大。検索・分類法に依存。※査読前

arXiv

■ 医療AI

幻覚検出も領域をまたぐと弱まる

一般領域でF1=0.915の検出器が、SciFactで0.52に。利用する領域での検証が必要。※査読前

arXiv